

Fecha Última Actualización: 16-06-2022 15:25:54

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Ivana Paola Fernandez Izarra
Edad : 32a 9m 17d
Dirección : Jaspe 1475

Rut : 26.496.124-6
Fecha Nacto: 30/08/1989
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2207859
Sexo : Femenino
Teléfono : 963292858

N° Epicrisis
307067

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 24/04/2022 03:32

Días Estadía: 53

Unidad de Egreso : Utac/ Utinx

Fecha Egreso : 16/06/2022 15:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemorragia subaracnoidea aneurismática

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha de ingreso a CASR: 24/04/2022
Fecha de ingreso a UPC: 24/04/2022
Fecha de ingreso a UTINCx: 15/05/2022
Fecha de reingreso a UPC: 19/05/2022
Fecha de reingreso a UTINCx: 27/05/2022
Fecha traslado a sala: 13/06/2022

Antecedentes:

¿ AM:Hipertensión arterial y obesidad, en tratamiento con olmesartán.

- Med: olmesartán e hidroclorotiazida

- Alergias: (-)

- Quirúrgico: (-)

- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)

- Hospitalizaciones: (-)

- Inmunizaciones: Sin vacunas.

- Social: De Venezuela. Educación superior incompleta (último año de Derecho, tesis pendiente). Hace 5 años vive en Chile. Trabaja en Call center.

Historia de ingreso:

23/04 ingresó a Hospital la Florida por cuadro de cefalea ictal, asociado a vómitos y aparente crisis convulsiva, se realizó TC de cerebro que mostró hemorragia subaracnoidea con patrón aneurismático, por lo que fue derivada a CASR donde fue evaluada por equipo de neurocirugía, quienes describen paciente en sopor superficial, parcial seguimiento de órdenes, pupilas isocóricas reactivas, sin focalidad motora. GCS 14.

TAC de ingreso HSR (24/04) informado con HSA extensa que compromete cisternas de la base de, cisuras de Silvio y convexidades bifronto-parietales y temporales. Además de 2 aneurismas: uno de 4x3 mm en ACI derecha y otro en la bifurcación del segmento de M2 de la ACM derecha de aproximadamente 4 x 3 mm también de bordes levemente irregulares.

Se realizó angiografía diagnóstica el mismo día, describiéndose: aneurisma sacular de la bifurcación de ACM derecha, dirigido hacia lateral, irregular, con 2 mamelones en el ápice, de 2,6 mm de alto x 4,5 mm de ancho, con cuello de 3,7 mm; aneurisma carótido-oftálmica derecha de proyección superior que mide 3,7 mm de alto x 5,2 mm de ancho, con cuello de 3 mm, de

Fecha Epicrisis : 16/06/2022 15:25

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 16-06-2022 15:25:54

Página 2 de 4

contornos regulares, pero con pequeño mamelón anterior. Sin hallazgos sugerentes de vasoespasmo.

El 24/04 se realizó exclusión quirúrgica de aneurisma de la bifurcación de ACM derecha con 2 clip (recto + semicurvo). Tiempos de isquemia: 3,5 + 2,5 minutos (en 2 tiempos). Control con videoangiografía + indocianina evidenció exclusión de aneurisma con anatomía vascular distal y proximal conservadas.

Además, se instaló DVE y se evacuó hematoma subdural de la convexidad y base de fosa anterior.

Se hospitalizó a la paciente en UPC para continuar monitorización y manejo intensivo.

Diagnósticos de ingreso:

- Hemorragia subaracnoidea aneurismática, Fisher III-IV, Hunt and Hess III, WFNS II.

Aneurisma de bifurcación ACM derecha clipada (14/04)

Aneurisma carótido-oftálmica derecha embolizada (14/04)

Crisis epiléptica reactiva (día de consulta)

- Antecedentes: HTA, obesidad

EVOLUCIÓN HOSPITALARIA por SISTEMAS:

1) Hemodinamia/ventilatorio: paciente inicialmente grave, en UPC con requerimiento de DVA Y VMI. Difícil manejo de presión arterial (por fluctuación importante), se suspenden DVA el 5/5. Evoluciona con HTA severa, requiriendo múltiples antihipertensivos orales en dosis máximas: carvedilol, hidralazina, Isosorbide, furosemida, clonidina, doxazosina. En UTI Ncx se logra mejor manejo de cifras tensionales y logrando estabilidad. Se suspende dosis PM de hidralazina. Se mantiene con monitorización no invasiva.

2) Respiratorio: con VMI protectora extubada el 11/05. Reintubada el 19/05 en contexto de sepsis de foco meníngeo, extubada el 21/05. Actualmente sin requerimientos de O2, se mantiene conducta expectante

3) Neurología/Neurocirugía:

HSA aneurismática con aneurismas excluidos el 24/04. Cursó con vasoespasmo leve a moderado tratado con angioplastia química. Completó profilaxis de vasoespasmo.

Cursó con AE al EEG por lo que se mantiene terapia anticonvulsivante.

DVE desde el 24/04, se realizó prueba de cierre el 14/05 frustró con LCR (+) para S.epidermidis, se realizó cambio el 19/05. Se retiró DVE el 11/06, sin incidentes. Se mantiene neurovigilancia, medidas de neuroprotección, terapia anticonvulsivante. TC control hoy:

4) Infecciones:

Intercurrencias infecciosas

24/04 LCR (+) S.epidermidis, considerado contaminación

Neumonía asociada a VMI por SAMS (CAET 01/05) tratada con Meropenem y luego Cloxacilina

Bacteremia por S.epidermidis MS en tratada con Cloxacilina (FI 03/05)

Antecedentes LCR del 24/04 (+) S. Epidermidis, fue interpretado como contaminación.

16/05 LCR Prot 0,41 Gluc 42 GB 370 PMN 62 MN 38 Gram NSOB Cul S.epidermidis MR

SO GB 25-30/c GB 0-3/c Bact escas UC (+) ERV B

31/05 LCR Prto 0.21, Gluc 58, Cel 30, Gram NSOB

Cursó con ventriculitis tratada, inicialmente con terapia empírica con Meropenem y Vancomina, con cultivos se suspendió Meropenem. NP Vanco 31/05 30. Completó 15 días de Vancomicina (19/05-04/06), suspendida ante sospecha de RAM (fiebre sin otro foco).

Cultivo de portación (hisopado rectal) del 17/5/22: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa + , KPC + . Se deja en aislamiento de contacto.

Actualmente:

Último peak febril 02/06, que se interpretó como RAM por Vancomicina. Se suspende y evoluciona afebril y PI bajos durante la última semana. Se suspendió Linezolid ayer (24 hrs posterior a retiro de DVE). Se mantiene aislamiento de contacto por portación de múltiples agentes resistentes: ERVB, KPN KPC. Últimos LCR negativos.

4) Rehabilitación: Kinesioterapia motora sentar en borde de cama. FNA no es conflicto actual.

Fecha Epicrisis : 16/06/2022 15:25

Página 2 de 4

5) Nefrología: HTA refractaria en mujer joven. Evaluada por nefrología que solicita estudio:

- EOC pH 7 Nit - Prot - Gluc N GB 3-6/c GR 0-3/c Bact escasas

- IPC ProTU Aisl < 0,07 CreatUAisl 17,6

- Cortisol AM 10,9 TSH 2,16 T4L 1,03

- Ecodoppler renal 09/06 Examen sin signos de estenosis hemodinámicamente significativa a nivel de las arterias renales

Se mantiene terapia antihipertensiva, sin diuréticos, ni IECA, pendiente realizar estudio con renina, Aldosterona, Cortisol en orina de 24 horas (ya compra externa). (P) resultado de SOC (muestra tomada y enviada hoy 13/06). En seguimiento por nefrología.

6) Ginecológico: cursó con vulvovaginitis, se administró monodosis de Fluconazol EV 28/05, suspendida Nistatina a los 3 días, pese a indicación de 7 días. Ante persistencia de síntomas se indicó tratamiento por 7 días con Nistatina (04-10/06)

7) Psiquiátrico: Paciente con delirium hiperactivo resuelto en plan de titular a la baja quetiapina de manera escalonada. Se reduce hoy dosis AM a la mitad. Se sugiere evaluación por equipo de salud mental al alta por importante componente ansioso de paciente.

9) Profilaxis: Se mantiene profilaxis de UPP. Se reanuda profilaxis anticoagulante hoy 13/06.

Imágenes relevantes :

24/04 TAC cerebro: extensa HSA en cisternas de la base de, cisuras de Silvio y convexidades bifronto-parietales y temporales, algo mayor a derecha. Leve cantidad de contenido hemático el cuarto ventrículo. Aneurisma sacular de 4 x 3 mm en el segmento supraclinoideo de ACI derecha, con borde posterior levemente regular. Otro aneurisma sacular se identifica la bifurcación del segmento de M2 de la ACM derecha de aproximadamente 4 x 3 mm también de bordes levemente irregulares.

11/06 TAC de cerebro: DVE in situ, sin variación en tamaño ventricular en relación a TC previo.

Ecodoppler renal 09/06: Examen sin signos de estenosis hemodinámicamente significativa a nivel de las arterias renales

Exámenes relevantes:

Estudio de función renal: EOC pH 7 Nit - Prot - Gluc N GB 3-6/c GR 0-3/c Bact escasas. IPC ProTU Aisl < 0,07 CreatUAisl 17, Cortisol AM 10,9 TSH 2,16 T4L 1,03. (P) SOC.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES:

Ventriculitis por S. epidermidis en tratamiento

Bacteremia por S. epidermidis MS en tratamiento

HSA Fischer III-IV, HyH III, WFNS II día 24

Aneurismas ACM derecha y carotideo oftálmico, excluidos 24/04

Vasoespasma leve-moderado ACI, ACA, y ACM derechas, leve ACA y ACM izquierdas. Angioplastia química 28/04

DVE 24/04; 19/05-11/06

Delirium hiperactivo resuelto

Vulvovaginitis tratadas

ITU tratada

Neumonía asociada a VMI por SAMS tratada

HTA d e difícil manejo obs H T A s e cundaria

Obesidad

Portadora de ERV y carbapenemasas (+)

Dado paciente en buenas condiciones, sin DVE, cifras tensionales dentro de rango normal y TAC de hoy en mejoría se decide traslado a sala básica.

En sala básica, buena evolución, de alta en rehabilitación sin requerimiento de asistencia. Evaluada por Nefrología con estudio pendiente, se puede seguir de forma ambulatoria. Se decide alta.

Diagnóstico de Egreso

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA DE ARTERIA CEREBRAL MEDIA -

Fecha Epicrisis : 16/06/2022 15:25

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:04

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 16-06-2022 15:25:54

Página 4 de 4

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen liviano alto en fibra

Paracetamol 500mg, 2 comp cada 8 horas por 5 días

Omeprazol 20mg al día por 5 días

Acido Valproico 250mg cada 8 horas VO

Bisoprolol 5mg, 1/4 comp cada 12h VO

Hidrazalina 50mg, 1 comp al día VO

Nifedipino retard, 20mg cada 12h VO

Quetiapina 50mg, 1/2 comp AM y 1 comp PM VO

Control con Neurocirujano Dr. Nicolás Lecaros en CDT H Sotero del rio el día 4 de Julio a las 14h, agendar directamente, si no, autorizado sobrecupo.

Control con Nefrología a la brevedad para completar estudio de HTA solicitado, pendiente. Solicitar hora en CDT.

Control con Neurología policlínico de epilepsia a la brevedad. Solicitar hora directamente.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Cabeza Línea Media 30°

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles



Magdalena Virginia Torres Giglio

BECADO

Pablo López Lobos

Becado/Residente



John Gutierrez González

Médico Tratante (Staff)